

Skills locomoteurs B3.8

Support d'apprentissage – Genou

Contenu : Dr. Robin Martin, Réalisation graphique : Danielyan Vagan (Travail de Master dirigé par Dr. Wehrli)

<u>Nom du test ou de la manœuvre</u>	<u>Description</u>	<u>Photos ou illustration</u>
a. Présentations cliniques fréquentes indiquant la réalisation du test	a. Position et action du patient	
b. Définition de la positivité	b. Action de l'examineur	
c. Implications cliniques	c. Pièges techniques et astuces	

LCA

Suspicion clinique d'une rupture du ligament croisé antérieur : test de Lachman

- a. douleur brutale et importante, accompagnée d'un gonflement de l'articulation (épanchement) et d'une boiterie. Ensuite : évolution vers des plaintes d'instabilité et lâchages du genou, particulièrement marquées lors d'activités qui impliquent des changements de direction ou des pivots sur la jambe concernée, sans douleurs.
- b. Majoration de la laxité antérieure du tibia par rapport au fémur comparativement au côté opposé. Absence d'arrêt sec en fin de course.
- c. Examens complémentaires : Radiographies standards (avulsion de Segond au versant antéro externe du genou dans 10 % des cas), IRM pour rechercher les lésions associées. Environ 50 % des lésions du ligament croisé antérieur s'accompagnent d'une lésion de ménisque, du cartilage, ou d'un autre ligament. Traitement : physiothérapie pour récupération des amplitudes articulaires, antalgie et tonification. Ensuite, une prise en charge chirurgicale est recommandée chez les jeunes patients, les patients actifs (sportifs, travailleurs manuels) et ceux présentant une déchirure méniscale. L'intervention est réalisée sous arthroscopie et a pour objectif de reconstruire le ligament à son emplacement anatomique. Pour ce faire, on prélève sur le patient (autogreffe) un segment de tendon (ischio-jambiers, tendon du quadriceps ou tendon rotulien)

- a. Patient en décubitus dorsal sur table d'examen, jambe pendante sur le bord de la table
- b. L'examineur se place en bout de table, la cheville du patient entre ses jambes. Une main stabilise la cuisse du patient, en la prenant juste au-dessus du genou, par son versant externe. Le genou en flexion à 15 degrés et le patient est relâché. La seconde main de l'examineur est appliquée au tibia proximal, par son versant interne et réalise une translation antérieure.
- c. Pour éviter des faux positifs : maintenir la cuisse stable. Pour éviter des faux négatifs : le patient doit être relâché, jambe pendante. Positionner les mains le plus proche de l'articulation. L'examen doit être comparatif au côté opposé.

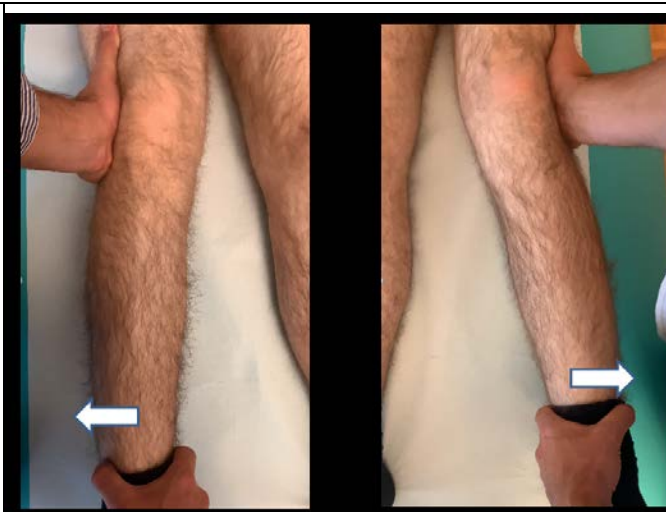


LCI

Suspicion clinique d'une lésion du complexe ligamentaire interne : test du valgus stress

- a. douleur en regard de l'interligne interne. Rarement : sensation d'instabilité (Lésion complète du complexe ligamentaire interne). Lésion ligamentaire la plus fréquente du genou. Traumatisme en valgus. Rupture du faisceau profond à basse énergie (grade 1), puis du faisceau superficiel (grade 2) et poplité oblique à haute énergie (grade 3). Pas d'épanchement si lésion isolée.
- b. - Augmentation de la laxité au valgus forcé avec le genou à 20 degrés de flexion, comparativement au côté opposé : lésion du faisceau profond et superficiel du complexe ligamentaire interne (Grade 2). - Moindre laxité au valgus forcé avec le genou en extension : lésion complète du complexe ligamentaire interne (Grade 3), voir du pivot central (ligament croisé antérieur et/ou postérieur).
- c. Examens complémentaires : souvent non nécessaire. IRM si grade 2-3 suspecté à l'examen clinique. Le complexe ligamentaire interne a un très bon potentiel de guérison sans instabilité résiduelle sous traitement conservateur. Traitement : Physiothérapie. Attelle articulée pour 6 semaines si grade 2 ou 3 pour 6 semaine

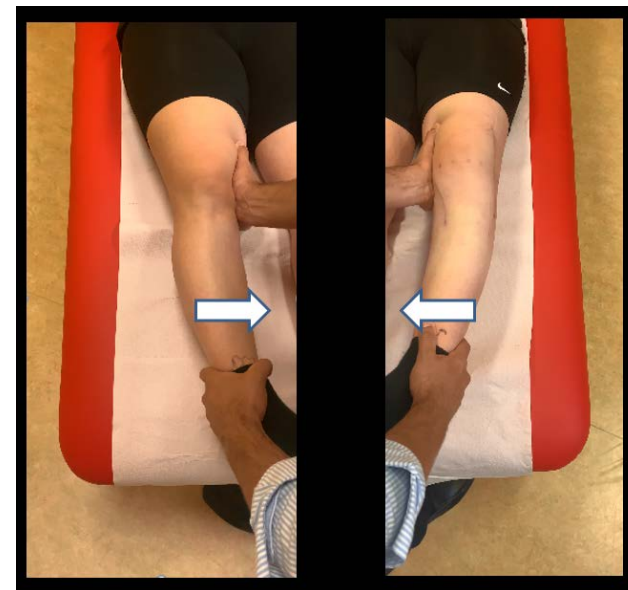
- a. Patient en décubitus dorsal sur table d'examen, les 2 membres inférieurs sur la tables
- b. L'examineur se place en bout de table. Une main stabilise le genou du patient, en la prenant appui sur son versant externe. La seconde main de l'examineur est appliquée juste au-dessus de la cheville, à son versant interne. Elle réalise une translation latérale. La manœuvre est réalisée sur genou en flexion à 15 degrés et ensuite avec le genou en extension.
- c. Pour éviter des faux positifs : maintenir la cuisse et le genou stable. Il ne doit pas y avoir de mouvement de rotation de la hanche (rotule reste au zénith). L'examen doit être comparatif au côté opposé. Pour éviter des faux négatif : le patient doit être relâché.



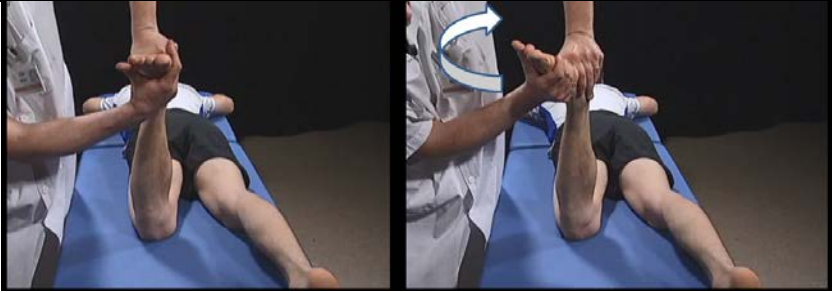
Suspicion clinique d'une lésion du ligament collatéral externe: test du varus stress

- a. douleur en regard de l'interligne externe. Rarement : sensation d'instabilité (Lésion complète). Lésion ligamentaire nettement plus rare que le collatéral interne et associée le plus souvent à une lésion du pivot central (ligament croisé antérieur et/ou postérieur). Traumatisme en varus à haute énergie. Pas d'épanchement si lésion isolée
- b. - Augmentation de la laxité au varus forcé avec le genou à 20 degrés de flexion, comparativement au côté opposé : lésion complète du ligament collatéral externe.
 - Moindre laxité au varus forcé avec le genou en extension : lésion complète du ligament collatéral externe avec lésion du pivot central (ligament croisé antérieur et/ou postérieur).
- c. Examens complémentaires : IRM. Le ligament collatéral externe n'a pas de potentiel de guérison sans instabilité résiduelle sous traitement conservateur. Traitement chirurgical pour reconstruire le ligament à son emplacement anatomique. Pour ce faire, on utilise un segment de tendon que l'on prélève le plus souvent sur le patient (autogreffe).

- a. Patient en décubitus dorsal sur table d'examen, les 2 membres inférieurs sur la table
- b. L'examineur se place en bout de table. Une main stabilise le genou du patient, en la prenant appui sur son versant interne. La seconde main de l'examineur est appliquée juste au-dessus de la cheville, à son versant externe. Elle réalise une translation médiale. La manœuvre est réalisée sur genou en flexion à 15 degrés et ensuite avec le genou en extension.
- c. Pour éviter des faux positifs : maintenir la cuisse et le genou stable. Il ne doit pas y avoir de mouvement de rotation de la hanche (rotule reste au zénith). L'examen doit être comparatif au côté opposé. Pour éviter des faux négatifs : le patient doit être relâché.



Suspicion clinique d'une lésion traumatique du ménisque interne ou externe: test de Mc Murray a. patient jeune, historique de traumatisme, généralement en flexion/rotation, retrouvée dans plus de 50% des déchirures du LCA. b. La manœuvre est positive si elle reproduit un ressaut ET une douleur concomitante. c. Sensibilité 29%, Spécificité 96 %. Examen complémentaire le plus souvent nécessaire : IRM. Le traitement est chirurgical, pour suture de la déchirure méniscale, dans un délai court. La ménisectomie (résection) doit être évitée car augmente le risque d'arthrose. Elle ne sera considérée que si la lésion est irréparable ou en zone avasculaire (1/3 central du ménisque).	a. Patient en décubitus dorsal sur table d'examen, les 2 membres inférieurs sur la tables b. L'examineur se place le long de table. Le genou est placé en flexion maximale. - Pour le ménisque interne : une main stabilise le genou du patient, en la prenant appui sur son versant externe. La seconde main de l'examineur est appliquée juste au-dessus de la cheville, à son versant interne. Elle réalise une rotation externe. Le genou est ensuite amené progressivement en extension. - Pour le ménisque externe : une main stabilise le genou du patient, en la prenant appui sur son versant interne. La seconde main de l'examineur est appliquée juste au-dessus de la cheville, à son versant externe. Elle réalise une rotation interne. Le genou est ensuite amené progressivement en extension. c. Pour éviter des faux positifs : ne pas considérer la manœuvre comme positive si elle déclenche un craquement ou une douleur isolé.	
---	--	---

Suspicion clinique d'une lésion traumatique du ménisque interne ou externe: test d'Apley (grinding test). a. patient jeune, historique de traumatisme, généralement en flexion/rotation, retrouvée dans plus de 50% des déchirures du LCA. b. La manœuvre est positive si elle reproduit un ressaut ET une douleur concomitante. c. Sensibilité 16%, Spécificité 80 %. Examen complémentaire le plus souvent nécessaire : IRM. Le traitement est chirurgical, pour suture de la déchirure méniscale, dans un délai court. La méniscectomie (résection) doit être évitée car augmente le risque d'arthrose. Elle ne sera considérée que si la lésion est irréparable ou en zone avasculaire (1/3 central du ménisque).	a. Patient en décubitus ventral sur table d'examen, les 2 membres inférieurs sur la tables b. L'examineur se place le long de table. Le genou est placé en flexion à 90 degrés. - Pour le ménisque interne : une main applique une pression au niveau du talon, de haut en bas, vers la table. La seconde main de l'examineur est appliquée au niveau du pied. Elle réalise une rotation externe. - Pour le ménisque externe : une main applique une pression au niveau du talon, de haut en bas, vers la table. La seconde main de l'examineur est appliquée au niveau du pied. Elle réalise une rotation interne. c. Pour éviter des faux positifs : ne pas considérer la manœuvre comme positive si elle déclenche un craquement ou une douleur isolé.	
---	---	---

Recherche d'un épanchement articulaire et distinction par rapport à une tuméfaction péri articulaire : les signe du glaçon (ou choc rotulien) a. patient décrivant son genou gonflé, le plus souvent à la suite d'un traumatisme. Il est alors important de distinguer une origine intra articulaire (épanchement, signe de gravité) d'une atteinte extra articulaire (tuméfaction des tissus, atteinte à priori plus bénigne). b. Positif si amplitude de mouvement antéro postérieur de la rotule est plus importante que du côté controlatéral, puis remonte au relâchement de la pression, comme un glaçon dans l'eau. Le contact de la rotule sur la trochlée crée un « choc » et elle remonte. c. la présence d'un épanchement laisse suspecter une atteinte intra articulaire. Elle doit mener à des investigations complémentaires (radiographie, ponction, IRM,...) selon le diagnostic différentiel des causes d'épanchement traumatique vs. non traumatique.	a. Patient en décubitus dorsal sur table d'examen, les 2 membres inférieurs sur la tables. b. L'examineur se place le long de table. Le genou est placé en extension à 0 degré. Une main est appliquée sur le cul de sac quadricipital, en sus rotulien. L'autre main est appliquée sur le versant antérieur du tibia proximal et est ainsi stable : avec l'index on applique une pression verticale, d'antérieur vers postérieur, sur la rotule. c. La main proximale chasse le liquide par simple fermeture de l'espace sous quadricipital : il est inutile de balayer/racler.	
--	---	--

Recherche d'une douleur à la palpation au niveau de l'interligne fémoro-tibial interne ou externe a. patient décrivant une symptomatologie douloureuse interne ou externe, le plus souvent à la suite d'un traumatisme. Il est alors important de distinguer si la douleur est centrée sur l'interligne (potentiellement intra articulaire, signe de gravité) ou si elle est située proximale/distale (atteinte extra articulaire, à priori plus bénigne). b. Positif si douleur reproduite/majorée à la palpation de l'interligne fémoro tibial interne/externe. c. la présence d'une douleur centrée sur l'interligne doit laisser suspecter une atteinte intra articulaire. Elle doit mener à des investigations complémentaires (radiographie, IRM).	a. Patient en décubitus dorsal sur table d'examen. b. L'examineur se place le long de table. Le genou est placé en flexion à 90 degrés. La manœuvre est réalisée sur les 2 interlignes fémorotibiaux. L'index est appliqué sur le débord antérieur du tibia (point E sur le schéma ci-contre). Ce débord est créé par le roll back (roulement postérieur, environ 1 cm) du fémur lors de la flexion. On repère ainsi le niveau de la partie antérieure du plateau tibial et on en déduit le niveau de l'interligne qui est incliné selon une pente de +/- 10 degrés en direction distale et postérieure. c. La palpation se fait le long de l'interligne ; on ne palpe pas à l'intérieur de l'interligne articulaire.	le niveau de l'interligne fémoro-tibial interne le niveau de l'interligne fémoro-tibial externe
---	--	---